Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Tapejara

Rua Coronel Gervásio, esquina com Avenida Sete de Setembro, 1525 - Bairro: Centro - CEP: 99950000 - Fone: (54)3046-9898 - Email: frtapejaravjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001250-04.2023.8.21.0135/RS

AUTOR: REJANE MARIA POSSER SOSSELLA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

REJANE MARIA POSSER SOSSELLA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação de Medicamentos, cumulada com pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, igualmente qualificado. A parte autora narrou ser portadora de Neoplasia Maligna de Ovário (CID C56), com diagnóstico de mutação de BRCA 1/2, necessitando do uso urgente e contínuo do inibidor de PARP (iPARP) OLAPARIBE, na dosagem de 300mg, via oral, duas vezes ao dia, sob pena de risco de evolução da doença e óbito. Disse que já se encontra em uso de Bevacizumabe (processo nº 5000217-47.2021.8.21.0135). Alegou que o medicamento pleiteado não é fornecido pela Farmácia de Medicamentos Especiais da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), exigindo aquisição particular. Ressaltou que o Olaparibe não possui genéricos ou similares e que o custo para seis meses de tratamento, estimado em R$ 281.245,20 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), é inviável para suas condições financeiras. Pugnou, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência para determinar o imediato fornecimento do medicamento pelo réu, sob pena de multa diária, e ao final, a procedência total da ação para que o fornecimento se tornasse definitivo. Adicionalmente, solicitou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Acostou documentos.

Recebida a inicial, foi determinada a juntada de documentação complementar para análise do pedido de AJG. Em relação ao pedido de tutela de urgência, foi determinada a solicitação de Nota Técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus) para análise da necessidade, adequação, urgência e possibilidade de substituição do fármaco (evento 4, DESPADEC1).

Sobreveio manifestação da autora (evento 10, PET1), reiterando o pedido de AJG.

Acostada Nota Técnica do NATJus (evento 12, NOTATEC1).

Intimada, a autora acostou exames complementares (evento 15, DESPADEC1, evento 19, PET1).

Citado, o requerido contestou (evento 18, CONT1). Manifestou-se quanto ao Tema 793 do STF e do alto custo do tratamento (Tema 06 do STF). Alegou que a competência é da União, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, requereu a improcedência do pedido da autora e a produção de provas. Acosotu documento.

Solicitada Nota Técnica do NATJus, foi acostada no evento 29, NOTATEC1.

Com a Nota Técnica favorável, o Juízo proferiu decisão (evento 31, DESPADEC1), *deferindo a tutela de urgência*. A decisão determinou que o Estado do Rio Grande do Sul fornecesse o medicamento OLAPARIBE na dosagem prescrita para seis meses de tratamento, ou viabilizasse sua aquisição imediata, ou efetuasse o depósito judicial do valor de R$ 281.245,20 (correspondente ao menor orçamento apresentado), no prazo de dez dias, sob pena de sequestro.

A autora, em manifestação subsequente (evento 39, PET1), informou o descumprimento da liminar, aduzindo que a Farmácia de Medicamentos Especiais não possuía o fármaco em estoque e não tinha previsão de recebimento, requerendo o bloqueio judicial dos valores. Em resposta, o Estado (evento 44, PET1) comunicou a ausência de estoque, mas informou sobre uma previsão de recebimento em 05/09/2023 e, *excepcionalmente, não se opôs ao bloqueio de valores*, chegando a indicar uma conta bancária para tanto.

Houve réplica (evento 44, PET1).

Na decisão de saneamento do feito (evento 46, DESPADEC1), o Juízo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, reiterando a solidariedade e mantendo a competência da Justiça Estadual. Adicionalmente, intimou as partes para se manifestarem sobre a produção de provas e solicitou nova informação ao Estado sobre a regularização do estoque do medicamento.

O Estado reiterou a ausência de estoque e, embora não se opusesse ao bloqueio de valores para a aquisição *de um ciclo* do tratamento, solicitou a expedição de ofício ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo de Passo Fundo com questionamentos sobre o tratamento oncológico no SUS (evento 49, PET1).

Deferida a remessa de ofício e decidido pela prejudicialidade do pedido de bloqueio de valores, determinando-se que o cumprimento provisório da sentença fosse distribuído em autos apartados (evento 51, DESPADEC1).

Opostos embargos de declaração (evento 55, EMBDECL1), que foram rejeitados (evento 59, DESPADEC1).

A autora interpôs Agravo de Instrumento, que resultou provido (53471154320238217000).

O Juízo reconsiderou a decisão anterior e *determinou o bloqueio dos valores de R$ 281.245,20* (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) para seis meses de tratamento, diretamente nas contas do Estado via Sisbajud, e a expedição de alvará ao Fundo Municipal de Saúde para a aquisição do medicamento. Na mesma decisão, reiterou a expedição de ofício ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo de Passo Fundo (evento 73, DESPADEC1).

O Estado impugnou o bloqueio, informando que a autora havia retirado o medicamento em 01/03/2024, conforme relatório AME, e que havia remessa pendente ao Município. Requereu a restituição dos valores e a intimação do Município para retirar a medicação, além de apontar que a receita médica da autora estava vencida (evento 81, PET1).

Determinada a expedição de alvará em favor do Estado para a restituição dos valores bloqueados e intimou a autora para informar se estava recebendo a medicação (evento 89, DESPADEC1).

O alvará de restituição foi expedido em 10/04/2024 (Evento 92).

A autora *confirmou que estava recebendo o medicamento* e solicitou que a empresa distribuidora/fornecedora fosse oficiada/notificada para responder aos questionamentos do Estado sobre os orçamentos e preços, por ser de sua responsabilidade (evento 97, PET1).

O Ministério Público declinou de intervir no feito (evento 103, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de hipótese de julgamento antecipado, porquanto as provas trazidas aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a dilação probatória (art.355, I, do CPC).

Vale registrar que o juiz é o destinatário das provas e tem o dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias (parágrafo único do art. 370 do CPC). Por isso, quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade, mas dever que a lei impõe ao julgador, em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

Ademais, as próprias partes não requereram dilação probatória.

Ausentes preliminares pendentes de análise, passo ao julgamento do mérito.

A presente demanda versa sobre o fundamental direito à saúde e à vida, bens jurídicos de natureza indisponível e primazia constitucional, em face da alegada omissão do Estado do Rio Grande do Sul no fornecimento de medicamento essencial para o tratamento de neoplasia maligna da autora.

Ressalto que a questão referente ao direito à saúde está estabelecida como uma garantia fundamental, uma vez que decorre do direito à vida e é também caracterizada como um direito social, conforme disposto no *caput* do art. 5º e no art. 6º da Constituição Federal.

Sendo assim, a saúde faz parte do rol dos direitos fundamentais, inerentes ao Princípio da dignidade da pessoa humana, que se constitui na garantia de uma gama mínima de direitos sem os quais não se consegue levar uma vida digna.

No mesmo sentido, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde como o dever do Estado, a saber:

> *Art. 196. **A saúde é direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Quando a Constituição Federal utiliza o termo "Estado", é no sentido *lato*, ou seja, englobando as três esferas do Poder Executivo (União, Estados e Municípios), sendo que o art. 198, parágrafo único, também da Constituição Federal, dispõe sobre a responsabilidade de todos os entes federativos pelo financiamento do SUS. Como dispõe o art. 23, da Constituição Federal:

> *"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:*
>
> *[...]*
>
> *II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."*

Da mesma forma, o Tema 6 do STF afirma que é *"Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo."*

Ainda, a Lei 8.080/90, em seu art. 2º, reiterou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições ao seu pleno exercício, disciplinando o SUS — Sistema Único de Saúde — e incumbindo aos entes públicos a prestação de serviços de saúde à população

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, a se ofertada através de sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, compete Estado, indistintamente por todos os seus entes federados — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — o dever de garantir aos administrados o direito à saúde e à vida, nos termos do art. 23, inc. II, da Constituição Federal (RE n.º 557.548/MG, Rel. Min. Celso de Mello).

Destaco, inclusive, que o STF, quando da fixação de tese no Tema 793/STF, reafirmou, de maneira incontroversa, a presença da solidariedade entre os Entes Públicos na prestação de assistência à saúde pública à população.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada:

> *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"*
>
> *(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL — MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)*

Frisa-se, ainda, que a questão da competência foi deliberada no RE 1.366.243/SC, Repercussão Geral — Tema 1234 — na qual o STF, concedeu tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema, sejam observados os seguintes parâmetros:

> *(i) **nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:** a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;*
>
> *(ii) **nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados**: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;*
>
> *(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos **sem sentença prolatada**; diferentemente, os processos **com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023)** devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);*
>
> *(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.*
>
> *(...)*
>
> *(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) [Grifo nosso].*

Vale dizer, incide no caso nos autos a determinação do item II da decisão, uma vez que o fármaco postulado **não é padronizado**. Dito isso, necessária a observação do **Recurso Especial n.º 1.657.156 (Tema Repetitivo n.º 106)**, que fixou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

> ***(i)** Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> ***(ii)** incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
>
> ***(iii)** existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

A **necessidade do medicamento** foi comprovada pelo laudo médico que acompanha o pedido assinado por profissional devidamente habilitado (evento 19, ATESTMED2), o qual é suficiente para comprovar a alegação da parte, ou seja, a necessidade do uso do fármaco.

Somado a isso, a Nota Técnida (evento 29, NOTATEC1) emitida pelo NATJus foi de parecer favorável, conforme se verifica:

Conclusão

Tecnologia: OLAPARIBE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de carcinoma de ovário avançado

CONSIDERANDO a presença de mutação germinativa no gene BRCA conforme novos laudos anexos.

CONSIDERANDO a falha de tratamento a 2 esquemas de quimioterapia baseada em platina

CONSIDERANDO que há dados científicos sustentando o uso de olaparibe nesta situação

Página 3 de 4

CONCLUI-SE que HÁ DADOS TÉCNICOS sustentando o uso de olaparibe como tratamento de resgate após falha de quimioterapia baseada em platina em pacientes com câncer de ovário e mutação somática de BRCA.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

Diante disso, denota-se que o referido tratamento é indispensável à manutenção de sua saúde, justificando a confirmação da antecipação de tutela deferida. Assim, preenchido o **primeiro requisito.**

Com relação à capacidade financeira da parte **(segundo requisito)**, compreendo que os documentos acostados nos autos corroboram a sua alegação de incapacidade de custear o tratamento de que necessita sem causar prejuízo ao sustento do núcleo familiar, diante do alto custo da medicação.

Em relação ao **terceiro requisito**, verifica-se que o fármaco se encontra devidamente registrado e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A Secretaria da Saúde municipal indeferiu o pedido administrativo de fornecimento do fármaco sob o argumento de que este não era disponibilizado pelo SUS (evento 1, CERTNEG25).

Além disso, verifico que a tutela de urgência foi deferida (evento 31, DESPADEC1), a qual passo a ratificar pelos fundamentos acima descritos.

Assim, por todo o exposto, considerando que restou amplamente configurada a existência da doença, a necessidade de utilização do fármaco e a insuficiência de recursos da autora para aquisição, consoante constou nos documentos que instruem o pedido inicial, tenho por imperioso julgar procedente o pedido inicial.

Da política nacional de prevenção e controle do câncer

Ressalto que a existência de CACON - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia ou UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia não afasta a responsabilidade do Estado em fornecer o tratamento postulado, ainda que a parte autora não realize o tratamento através de CACONs/UNACONs.

Nesse sentido:

> *RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.* ***FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. EXISTÊNCIA DE CACONS E UNACONS MANTIDOS PELA UNIÃO. IRRELEVÂNCIA.*** *DIREITO CARACTERIZADO. - Preliminar De Cerceamento De Defesa Afastada. Não se deve cogitar de cerceamento de defesa no caso concreto, pois apresentados elementos de convicção expressivos no feito aptos a fundamentar a decisão judicial. Depois, compete ao juiz, como destinatário da prova, determinar se as informações constantes nos autos são suficientes para formar sua convicção, como no caso dos autos. - Preliminar de Ausência de Fundamentação Afastada. A sentença atende aos comandos processuais vigentes, não havendo nulidade, revelando-se desnecessário qualquer outro fundamento além do exarado. Ressalto que a matéria objeto da lide é alvo de inúmeras ações iguais, e praticamente todas, com poucas exceções, decididas exatamente no mesmo sentido, ou seja, pela obrigação dos entes estatais de garantir o direito á saúde. - Mérito. A saúde consubstancia-se em direito social de segunda dimensão e de garantia fundamental expressamente consagrada na Constituição Federal de 1988, que a estabelece como sendo de direito a todos e dever do Estado, consolidando, inclusive, as ações e os serviços de saúde como de relevância pública, bem como impondo aos Entes Federados a responsabilidade pela prestação positiva, mediante a aplicação de políticas públicas para concretização de prerrogativas individuais e coletivas e garantia da existência digna.* ***Aliás, a responsabilidade dos Entes Federativos é solidária, de acordo com a disposição do art. 23, inciso II, da CF/88, que determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Tal conclusão também pode ser extraída da leitura do art. 196 da Lei maior, sendo que, esta responsabilidade não foi afastada pela existência dos denominados CACONs Centros de Alta Complexidade em Oncologia ou UNACONs Unidades de Alta Complexidade em Oncologia.*** *Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Na situação dos autos, da análise dos documentos que o acompanham, restou devidamente demonstrada a necessidade do medicamento Zoladex 3,6mg (GOSERRELINA) pela parte autora em razão da patologia (Neoplasia Maligna de Mama CID 10 C50) que lhe acomete, conforme se observa dos laudos médicos anexados aos autos. Outrossim, também é possível perceber o caráter emergencial no consumo do fármaco indicado pelo profissional da saúde que acompanha a parte autora. No mais, entendo que a parte desincumbiu de seu ônus na comprovação de sua hipossuficiência econômica para aquisição do medicamento mencionado. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006862437, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luciane Marcon Tomazelli, Julgado em 29/08/2018) [Grifo nosso].*

Da Denominação Comum Brasileira

De início, cabe destacar que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconhece a possibilidade de substituição do fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, conforme a Denominação Comum Brasileira, que possuem o mesmo princípio ativo (*Apelação Cível, N.º 70084379239, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-07-2020*).

Neste mesmo sentido é o Enunciado n.º 15 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, com o seguinte teor:

> *As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira — DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional — DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica.*

Frisa-se que o Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição do fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, conforme a Denominação Comum Brasileira, que possuem o mesmo princípio ativo.

Logo, ao evidenciar a urgência do tratamento e a carência financeira, bem como o registro do medicamento junto à ANVISA, à luz do Tema 106 do STJ, é necessário reconhecer a responsabilidade do réu pelo fornecimento do fármaco postulado, que deve observar a Denominação Comum Brasileira, nos termos do art. 3º da Lei 9.787/99.

Ainda, resta autorizada a compra do medicamento pela denominação comum brasileira, em razão do princípio da impessoalidade que rege a Administração Pública. Por norma, descabe a determinação de dispensação do medicamento pelo nome comercial, sendo imprescindível a observância da Denominação Comum Brasileira, **salvo situações excepcionais**

em que há oposição médica plausível em sentido diverso.

Neste ponto, registro que apesar de atualmente não existir no mercado a forma genérica do fármaco em comento, a dispensação pela DCB deverá ser garantida, especialmente pela ausência de ressalva no atestado médico juntado pela parte autora, bem como pela possibilidade de fabricação futura, situação que na hipótese do produto ser comercializado com preço inferior daquele atualmente fabricado e mediante concordância do médico assistente, o fármaco mais barato poderá ser dispensando, evitando-se, assim, oneração dos cofres públicos.

Por tais razões, a procedência do pedido é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por REJANE MARIA POSSER SOSSELLA contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para o fim de **CONDENAR** o réu a **fornecer** o medicamento OLAPARIBE na dosagem de 300mg, via oral, 2 vezes por dia de forma contínua, conforme laudos médicos juntados ao feito, ou disponibilizar o equivalente em dinheiro, observado o menor orçamento, sob pena de bloqueio de valores, em caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação. Torno definitiva a liminar concedida.

Custas pelo Estado, isentas conforme previsão do art. 5º, inciso I, da Lei 14.634/14. Condeno o demandado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º, do CPC, considerando o tempo de tramitação e o trabalho realizado.

Sentença publicada e registrada pelo sistema.

Decisão não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4º, inc. II, do CPC/2015.

Partes intimadas eletronicamente.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **AMANDA RODRIGUES DA GAMA, Juíza de Direito**, em 16/09/2025, às 08:49:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10089838979v11** e o código CRC **7df50011**.